

02 - 2-syndrome peritoneal sono maker

(0:00 - 0:32)

Les péripéritides peuvent être assez fréquemment généralisés ou localisés. En tant que péripéritides localisés, on se rend compte qu'un abcès de la catégorie péritoniale, les plus fréquemment rencontrés sont les abcès appendiculaires, et on peut avoir des abcès péridiculaires, des abcès de la fossile gauche. Donc le syndrome péritonéal, premièrement, la catégorie péritoniale est une qualité qui est très basse.

(0:33 - 0:49)

C'est une qualité virtuelle. La catégorie abominale, la catégorie péritoniale, elle est virtuelle. Virtuelle, ça veut dire que normalement, elle existe, mais elle n'existe pas.

(0:49 - 1:31)

Elle n'est pas rentrée. Elle n'est pas, c'est comme si vous aviez un ballon qui était rentré, affaissé, pour le rentrer et le faire, le rendre pratique. Il faut une catégorie régulière.

C'est le principal de la scénochirurgie. Donc on peut faire la scénochirurgie à un patient, et pour pouvoir travailler dans l'enceinte abominale, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va introduire une équipe, un programme et injecter de l'air. Comme ça, on va créer un espace de travail.

(1:32 - 1:43)

On va tenter, la catégorie abominale, de créer un espace de travail. Le corps, on ne le fera pas. On va le convertir à l'intérieur de l'enceinte abominale.

(1:43 - 1:58)

C'est ça le principe. Elle est vide, elle est sous vide. Il faut injecter de l'air, du gaz carbonique, du CO₂.

(1:59 - 2:14)

D'accord ? Donc je pense que, si vous voulez, on a voulu réaliser la première scénochirurgie, on a réalisé une scénochirurgie. Donc la qualité de l'enceinte abominale, elle est propre. Elle est propre.

(2:15 - 2:21)

On ne veut pas qu'elle soit vide. C'est l'absence. Elle est propre.

(2:22 - 2:26)

Elle est saine. Elle est saine. Il n'y a pas besoin.

(2:26 - 2:41)

C'est ça le principe de la scénurique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de microbe en enceinte péripérielle. On prend une petite péripérielle, ça veut dire que cette qualité péripérielle, elle est infectée.

(2:41 - 2:53)

Il y a un problème. Ça peut être une appendicite. Il y a un microbe qui pénètre cette enceinte péripérielle.

(2:53 - 3:02)

C'est la qualité qui est propre à l'extérieur. La qualité de la péripérielle, c'est que ce monde-là. C'est la même monde-là.

(3:03 - 3:15)

C'est comme si, par exemple, vous avez un monde qui fait 1m76 ou 1m75. Ça se passe. La qualité de la péripérielle, c'est le champ des carrés.

(3:16 - 3:51)

C'est la taille du compartiment. Ça se passe. C'est passé.

(3:52 - 4:17)

C'est tout ? Le réglant, en tant qu'une partie périmonisée, c'est le tiers supérieur. Et une partie non périmonisée, c'est le tiers inférieur. Donc, Madame le Président, elle mesure, dans un endroit, la taille du même milieu qu'en taille.

(4:29 - 5:12)

C'est l'empêchement, et selon l'endroit, elle peut exprimer l'indemnité pour parler de l'indemnité par le pas, par l'exemple d'une personne qui englobe et qui contourne l'intestin, on va appeler dans ce cas la serreuse de l'intestin. Lorsque la courbe fait du droit, on va l'appeler, la capture de l'huissou, très important, la capture de l'huissou, le pays droit, dans ce cas-là, le droit, on l'appelle la capture de l'huissou. Quand on englobe l'intestin, c'est la serreuse de l'intestin.

(5:12 - 5:38)

Quand le pays droit englobe le droit, c'est la serreuse du droit. Quand le pays droit permet le port

des vaisseaux du maison d'air, après la maison d'air intérieure, après la maison d'air intérieure, on va l'appeler maison d'air. Dans tout le pays droit, dans certains domaines, c'est le même, il est en continuité.

(5:38 - 6:01)

Pour bien comprendre, il faut revenir à la vie antérieure, à la vie anglophone. On ne peut pas comprendre le pays droit sans revenir à la vie anglophone. Au cours de la vie anglophone, quand le bébé a une semaine d'améliore, il a une tête et un cœur.

(6:01 - 6:17)

Entre les deux, il y a le tube digestif, le digestif primitif. C'est dans ce digestif primitif qu'il est dans l'embryon. Il est relié à la paroi antérieure par un vaisseau antérieur et à la paroi postérieure par un vaisseau postérieur.

(6:17 - 6:40)

Imaginez avec moi l'évolution de l'embryon dans le ventre de sa maman. Dans cet embryon, après qu'elle se mette à mélanger, on va assister et on va suivre l'apparition des organes. La phase d'organogénèse va commencer.

(6:40 - 7:07)

Cette phase d'organogénèse va commencer et on aura des cellules embryonnaires, des cellules qui vont se différencier dans le vaisseau antérieur pour donner naissance au bourgeon hépatique. Et des cellules dans le bourgeon postérieur qui vont être apportées naissance au bourgeon splénique. L'organogénèse a commencé.

(7:09 - 7:32)

L'ence digestif qui s'étend depuis l'oropharynx jusqu'au canal thoracal, c'est-à-dire à l'anus, est au centre de l'embryon. À un certain moment, cette ence digestif primitive va subir la rotation. La rotation de l'ence digestif primitive, c'est-à-dire que ce tube, l'ence digestif primitive, va se tordre.

(7:33 - 7:59)

Il va subir une portion dans le sens concret des aiguilles du vent, ce qui va ramener le poids à droite et la plaque à gauche. Le poids, alors, s'il bascule à droite, il est relié à l'ence digestif primitive qui va le fléchir du vent. Et il est relié à la paroi abominable au début, par l'évaporation et par l'évapotractive.

(8:01 - 8:20)

Vous voyez, donc, la rotation va permettre à l'ence digestif primitive de tourner à droite. Le

seconde va basculer à droite et le second à gauche. Le col en droit va subir un accolement secondaire.

(8:21 - 8:31)

Il va subir un accolement secondaire. Il est débit sur l'embryon et sur tout ça. Mais après la rotation, il va s'accoler grâce aux passières de tordre.

(8:32 - 8:47)

Donc il va subir un accolement secondaire. Un accolement secondaire du col en droit, c'est devant le col de droite. Devant le col de gauche, c'est un accolement descendant par le passière de tordre.

(8:48 - 9:02)

Et pour tout ça, il va falloir que vous parliez du périgouin. Le périgouin, on l'a dit tout à l'heure, il est propre, il n'y a pas de germes. Dans la cavité, même quand votre enceinte n'est pas de périgouine, elle est propre.

(9:06 - 9:19)

Alors la périgouine, c'est l'ensemble de manifestations similaires à l'infection de la cavité périgouinelle. C'est une urgence, selon l'État. Quand vous entendez le périgouin dire « j'ai fait un malade », c'est une urgence.

(9:19 - 9:28)

C'est qu'il doit être opéré en extrême urgence. Son principe est mis en jeu. Le diagnostic, il est clinique.

(9:28 - 9:41)

Vous pouvez faire le diagnostic en périgouine, bien que par la clinique. C'est-à-dire en cherchant ce qu'on appelle la contracture abdominale. C'est quoi la contracture ? C'est une défense généralisée de toute la cavité abdominale.

(9:41 - 9:48)

C'est une défense intensive. Elle ne se laisse pas vaincre. C'est-à-dire que l'abdomen est figé.

(9:48 - 9:58)

Le malade ne respire plus avec son abdomen. Maintenant, vous êtes assis en train de faire le cours et vous ne respirez pas avec votre abdomen. C'est-à-dire que l'abdomen est relâché.

(9:59 - 10:10)

Il peut respirer. Le diagnostic, tant qu'il est clinique, les étiologistes sont ravisés. Mais quand vous répondez aux téléphoniques, il y a des téléphoniques les plus fréquemment rencontrées en pratique courante.

(10:10 - 10:23)

Ce sont les téléphoniques secondaires. Quand on parle de téléphonique secondaire, ça veut dire secondaire aux appendicites et secondaire aux PPU, aux perforations bursées. Ce sont ce qu'on appelle les téléphoniques communautaires.

(10:23 - 10:31)

Au moins, les plus fréquentes dans la pratique quotidienne. Les autres sont rares, les téléphoniques. Les téléphoniques traumatiques sont rares.

(10:31 - 10:41)

Les téléphoniques post-opératoires, les téléphoniques gynécologiques, etc. Les téléphoniques primitives. Tout ça, ce sont des téléphoniques qui sont rares et exceptionnelles.

(10:43 - 10:53)

Alors la physiologie, vous avez laissé une page. Et on va revenir de temps à autre pour monter dans la physiopathologie. Il y a des points très importants dans cette physiopathologie.

(10:55 - 11:00)

Alors là, c'est l'idéologie clinique. La douleur, elle est constante. Donc, nous passons au raisonnement clinique.

(11:00 - 11:12)

Telle qu'on l'est aiguë, le médecin tend, c'est la douleur abominable. Et c'est la douleur qui doit la caractériser. Selon le point de départ, vous êtes réservé à un moment où vous allez commencer le raisonnement clinique.

(11:12 - 11:24)

Vous pensez que ce n'est pas ce qu'on a parlé tout à l'heure. Si par exemple, une maladie de malade, vous dites que la douleur a commencé à ce niveau-là. Dans la physiothérapie, on pense déjà à une téléphonique à peine visuelle.

(11:25 - 11:52)

Si mon patient, au cours de l'interrogatoire, je l'examine jusqu'au point d'une dépense généralisée, et en lui posant la question qui nous acceptera, il me dit que depuis 2 ou 3 jours, c'était au début à ce niveau-là. Donc, je vais commencer à penser à la téléphonique à peine visuelle. Il faut voir le mode de début, le type de la douleur, le siège, puis la généralisation.

(11:52 - 12:13)

Si par exemple, le patient me dit que le début, c'était épilastique, je commence à penser à la téléphonique par des patients vulnérables. Je vais déjà lui poser la question, est-ce que vous n'êtes pas ravis, est-ce qu'il y a l'annonce en vulnérables, etc. Donc, il faut poser la question sur les vomissements, nos aïeux, vomissements bileux, alimentaires, les troubles de transie.

(12:13 - 12:30)

Donc, au cours de la téléphonique, on revient à la physiopathologie. Si par exemple, un patient a une téléphonique, il a obligatoirement ce qu'on appelle un ileus reflex. C'est une infusion d'accompagnement.

(12:31 - 12:43)

Donc, l'intestin se paralyse. Il se paralyse, il n'y a plus le périspartisme intestinal physiologique et l'intestin ne peut plus bouger. C'est ce qu'on appelle l'ileus reflex.

(12:44 - 13:09)

C'est-à-dire que si par exemple, le malade, il a uniquement une téléphonique intermédiaire, mais il va y avoir un arrêt des matières et des gaz secondaire à cet ileus reflex. Donc, la couleur, c'est le maître-seigneur. Les vomissements peuvent être des aïeux alimentaires et on aura surtout un arrêt des matières et des gaz.

(13:09 - 13:21)

En plus de ça, on va assister à la constitution d'un troisième secteur. Une caporation intermédiaire. Le liquide digestif va commencer à couler.

(13:21 - 13:46)

Le liquide cul va couler. Si il coule dans l'ensemble de l'enceinte abdominale, c'est l'explication d'une périphonie généralisée. Parfois, grâce aux moyens de défense de l'organisme, les intestins et les vivants, ils peuvent colmarer la zone qui est malade, qui pourrait être une appendice, et ça peut augmenter ce qu'on appelle un plastron.

(13:47 - 14:23)

Un plastron, c'est-à-dire qu'ils vont barricader la zone qui est malade, et le malade, au lieu de

dévoluer vers une périphonie généralisée, il va dévoluer vers un accès, à la fin de l'hiver, c'est ce qu'on appelle une périphonie localisée. Au lieu de faire une périphonie généralisée, il peut, grâce à ses moyens de défense, grâce à son emploi, il va évoluer vers une périphonie localisée, vers l'accès. Les signes généraux, la fièvre, c'est en fonction du type de l'organe qui est perforé.

(14:24 - 15:00)

Alors, vous devez savoir que le profil bactériologique, ou bien des bactéries, sont absents de l'estomac. L'estomac entre 10 à la puissance 3, germe dans le meilleur des cas, c'est-à-dire 10 à la puissance 3 après un repas, mais rapidement, grâce à l'HCR qui est cette piété, ça va se déployer et il n'y aura plus de germes. Donc, au niveau de l'estomac, le profil écologique bactérien de l'estomac est relativement propre.

(15:01 - 15:28)

Le geste humain, il est beaucoup plus sale. Si vous descendez dans le geste humain, on a 10 à la puissance 3, 10 à la puissance 6 germes par millimètre cube. Au niveau de l'idéal, c'est 10 à la puissance 6, d'accord ? Et dès qu'on franchit la balle de Bohin, dans le second, il y a 10 à la puissance 12 germes par millimètre cube.

(15:28 - 15:55)

Et on est au niveau de l'estomac 10 à la puissance 14, des milliards et des milliards de germes. Donc, le profil bactérien, il diffère selon le segment intestinal qui a été perforé. Et c'est la raison pour laquelle, lors des péritonites par perforation de l'ulcère, quand vous allez vers la gare le mois de Ramadan et que vous allez recevoir des péritonites par perforation de l'ulcère, vous allez voir que le malade, il a une contracture généralisée.

(15:56 - 16:27)

Mais si vous le voyez les premières heures, la température va être normale. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de développer en ce moment-là une péritonite chimique du liquide qui va passer à travers l'ulcère et qui est perforée dans la cavité arotonate, va contenir uniquement de la bile et c'est une inflammation chimique de la cavité péritonale. Donc, le malade qui a une TPU, il n'a pas de température, il n'a pas de fièvre pendant les premières 24 heures.

(16:28 - 17:06)

Ce n'est que s'il n'est pas opéré au bout de 24 heures qu'il va commencer à développer de la fièvre. Donc, fonction du type dénonculant, par sens au cours des 6 premières heures au cours d'une péritonite chimique, c'est-à-dire une péritonite par perforation d'ulcère, gastro-démun, alors que la température est élevée, donc une péritonite à la fin de l'huile d'air ou par perforation urérique ou par perforation chronique. Les signes de choc, le début il est latent, il peut y avoir du tachycardie, des stresseurs, et de la tension artérielle qui est agressée.

(17:06 - 17:46)

Pourquoi ? Parce que, tout simplement, le malade qui est une péritonite généralisée, il va développer ce qu'on appelle un troisième secteur. Un troisième secteur dans la cavité péritonale. Les sécrétions de liquide, la stagnation des liquides dans la cavité péritonale, le liquide digestif, la paralysie du liquide digestif qui engendre un ileus réper, souvent brisant, va engendrer une stagnation de l'évolution des liquides digestifs.

(17:46 - 18:06)

Vous savez très bien qu'au cours de la journée, les 24 heures, on déglutit inconsciemment 6 litres de liquide qui vont passer dans le liquide digestif. La salive, 1 litre et demi inconsciemment. Maintenant, vous êtes en train de déglutir votre salive inconsciemment.

(18:07 - 18:30)

Les sécrétions gastriques, 1 litre et demi de sucres gastriques, 866 jusqu'à 1 litre de bière, 1 litre et demi de sucres non-calorisés. Si vous faites la somme de ce que vous vient de décrire, vous allez trouver 6 litres qui vont circuler dans le jus d'une angule par jour. Heureusement, il y a ce qu'on appelle le cycle entero-hépatique.

(18:30 - 19:05)

Grâce à ce cycle entero-hépatique, on veut réabsorber ce liquide, la salive, la bière, etc. On réabsorbe et on perd peu de liquide et peu d'électrolyte parce que ces 6 litres qui sont très riches par les électrolytes, par le sodium, le potassium, le calcium, etc., les anticorps, les immunoglobulines, etc. Cette masse qui vient est en augment perpétuel au cours des 24 heures.

(19:07 - 19:13)

Quand on est malade, on a une téléphonie. Cette masse qui vient est bloquée. Elle ne circule plus.

(19:14 - 19:37)

Grâce à l'infection, à l'immunisation de l'absorption intestinale, à la paralysie du glycine et du serrefex, il y aura une masse qui vient très importante, ce qui va engendrer une baisse de la conscience intérieure, une déshydratation. De manière à ce que vous allez l'examiner, vous allez trouver la crise de déshydratation. Les corps vulnérables qui sont enfoncés, c'est la sécheresse de la muqueuse.

(19:38 - 20:06)

Il y a ce glycine de déshydratation, une baisse de la conscience intérieure et un choc

hypothalonique grâce à cette peritonite. Parmi les réflexes que vous devez avoir quand vous allez faire une diagnostique d'un malade qui est porteur d'une peritonite généralisée, c'est d'assurer la mise en condition du patient. Avant le traitement chirurgical, il faut préparer le patient.

(20:07 - 20:27)

Il faut penser à le réhydrater, à prendre des droits bénins pour le préparer à l'intervention chirurgicale, pour le préparer au bloc opératoire. C'est-à-dire que mon patient est choqué, il a un choc, il peut revenir. Peu importe la raison ou la cause de la peritonite.

(20:28 - 20:37)

Je ne veux pas savoir pour l'instant est-ce qu'il a une peritonite appendiculaire ou par préparation financière. Mais ce qui m'intéresse, c'est de le préparer. C'est ce qu'on appelle la mise en condition.

(20:37 - 20:58)

Donc je vais prendre au moins un droit bénin, encore un droit bénin, pour commencer le remplissage, la rééquilibration du doigt électronique, etc. pour pouvoir avoir une conscience intérieure correcte. Parce que si vous l'opérez d'emblée, sans cette préparation, le malade ne peut faire un avécatio respiratoire, secondaire à l'injection de drogue de la médecine.

(20:58 - 21:16)

Si le malade n'est pas préparé. Donc il faut obligatoirement préparer le patient à l'intervention de celui-là, par une réexpansion hydroélectrique et par un remplissage vasculaire. C'est la raison pour laquelle la physiothérapie est très importante.

(21:19 - 21:45)

En termes d'inspection, on doit chercher un abdomen immobile, qui ne respire pas, rétracté. Le patient est en dégustus dorsal, le long du corps, les cuisses, les chins, pour qu'il permette un relâchement des muscles de la paroi. Les mains doivent être réchauffées.

(21:46 - 22:15)

Vous ne pouvez pas, dans un doigt de janvier, février, alors qu'il fait froid, palper l'abdomen de votre patient sans faire le mouvement de les réchauffer pour ne pas agresser le patient. Il faut chercher la contracture abdominale. La contracture abdominale, c'est un signe qui est patognomique de la péritomie.

(22:17 - 22:32)

Les muscles de la paroi abdominal sont contractés spontanément, en permanence et de manière douloureuse. Cette contraction peut être localisée. On appelle, dans ce cas-là, la défense.

(22:33 - 23:26)

Dans le cas d'une appendicite non compliquée de la péritomie, il peut y avoir une défense de la paroi abdominal, de la postérieure, et en termine les amener par le toucher rectal qui va trouver un doublement qui est bon et douloureux. Pour conclure, chaque fois qu'on trouve une contracture ou une défense abdominale et un doublement qui est douloureux et bon, il faut penser à la péritomie. C'est un diagnostic qui est clinique et pour le confirmer, on peut demander des examens complémentaires notamment une radiographie de l'abdomen qui va chercher un pneumopéritoine c'est-à-dire un croissant gazeux sous-clinique sur l'ASP.

(23:28 - 23:52)

Voici ce croissant gazeux. L'ASP, il faut le dénommer en posant deux mots lorsque vous allez rédiger le bilan de radiologie pour préciser ASP, deux mots. Sinon, le patient va faire la radio-toucher sur le banc K, mais vous n'allez pas voir ce croissant gazeux qui correspond au passage de l'air dans la cavité péritoniale.

(23:52 - 24:47)

Tout à l'heure, on a dit que la cavité péritoniale elle est virtuelle, elle n'existe pas. D'accord ? Elle est virtuelle. Donc, quand le malade arrive à une serre perforée, il y aura passage de l'air dans la cavité péritoniale et puisque l'air a une amontance à l'entrée de l'eau, il va être bloqué par la contrainte de l'hypothèque droite et ici, on a l'air qui s'interpose entre le banc hépatique le banc hépatique, ce sont les segments les plus lumineux du poids à savoir les segments 7 et 8. 7 et 8. Donc, le croissant gazeux, il est là et c'est ça, le croissant gazeux qui, chez un malade qui consulte pour une brûlure abdominale, une contracture, c'est automatiquement un effet perforation du cerveau.

(24:50 - 25:38)

Donc, les examens complémentaires, sur la radio l'abdomen sans préparation, on peut noter une grisaille diffuse qui est synonyme d'un épanchement liquidien de la cavité abdominal, quand on peut trouver des fibroïdroses fibroïdroses aussi bien que du liquide que du croissant. Des fibroïdroses mixtes, d'hybrides et de croissants ça veut dire que c'est habillé jusqu'à l'axe dans le cadre de cette pathologie qui est la péritonite. Le chroniqueur étoilé, on peut également le chercher à l'hémographie car un bon radiologue, un hémographe expérimenté peut facilement faire le diagnostic du chroniqueur étoilé et peut le retrouver.

(25:38 - 26:12)

Vous voyez ici une courbe échographique, ici c'est le ventre hépatique et ici on a le diaphragme et

ici l'air qui s'interpose entre le ventre hépatique et l'améliore du diaphragme. Donc chez le malade, ça fait l'homogénéroïde et dans le contexte du téléphage on l'a vu, ça fait le croissant du cerveau. L'homogénéroïde on peut également le confirmer et le chercher sur une courbe scalandrale, sur l'abdomen et sur l'ADN arrondissant.

(26:12 - 26:45)

Ici vous voyez des bulles d'air et un croissant à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et vous voyez également l'étanchement péripatique. Dans les examens compérateurs bien sûr vous demandez l'ASP mais surtout 3.3. Le premier examen à demander c'est l'échographie abdominale qui va mettre en évidence l'étanchement liquéen.

(26:45 - 27:54)

Vous savez très bien que l'étanchement normalement n'existe pas au niveau de la qualité périporique. Quoi que l'étanchement existe au niveau de la qualité périporique. Physiologiquement maintenant si on fait une échographie avec un appareil sophistiqué d'une génération on va trouver un étanchement mais c'est un étanchement qui est liquéen qui est physiologique qui permet le brassage et les mouvements d'aisance les uns par rapport aux autres.

Parce que normalement physiologiquement on a un étanchement péripornial physiologique qui est de quelques cc jusqu'à 50 cc 100 cc selon les individus. Donc grâce à ce liquide péripornial les aisances intestinales les uns par rapport aux autres c'est une barrière et un moyen de défense entre les microbes, entre les germes etc. Vous savez très bien qu'on a tout à l'heure parlé de milliards et de millions de germes une bombe bactériologique dans l'intestin de l'homme.

(27:54 - 28:24)

Mais grâce à ces barrières intestinales et grâce à cette paroi périporniale et à ce liquide péripornial on se défend contre ces germes là. Même si à passage pour une raison ou une autre il y a un germe ou deux ou trois ils vont être attaqués par ce liquide péripornial qui contient des antibodies qui contient des cellules de l'immunité, des macrophages des lymphocytes etc. Mais ce liquide il est limpide il n'est pas éthogène.

(28:24 - 28:31)

Le liquide péripornial physiologique il est limpide. Il est clair. Il n'est pas éthogène.

(28:32 - 29:08)

Quand est-ce qu'il devient topologique ? Quand il devient éthogène. Lorsque le radiologue qui fait l'éthiopathie trouve un liquide assez abondant on le place dans la loge de Borisson dans les endroits des pires et il remarque, il mesure lorsque le radiologue lorsque vous allez faire un

spécialité radiologique vous allez mesurer l'écogénosité du liquide que vous allez trouver. Et si par exemple le radiologue vous dit que c'est un liquide qui est éthogène ou hyper éthogène, ça veut dire que il n'est plus limpide, il n'est plus clair et c'est un liquide qui contient des germes qui deviennent éthogènes.

(29:08 - 35:54)

Ça veut dire que le liquide il contient beaucoup de bactéries beaucoup de bactéries dégradées par les lymphocytes etc. Et quand le liquide il devient trop épais trop éthogène il ne peut plus être réabsorbé parce que normalement le liquide péripénal c'est un liquide péripénal qui est physiologique qui est tout à fait normal il circule il passe de la cavité qu'il nous place, il remonte le long de la frontière hyper-hypercolique et il est réabsorbé au niveau de l'espace sous-préliminaire à ce niveau-là au niveau de l'espace sous-préliminaire il y a ce qu'on appelle l'estomac des portes qui permettent à ce liquide de rejoindre le canal lymphatique et de nettoyer la cavité péripénale c'est comme si on avait la cavité péripénale et puis on peut faire le ménage et puis le liquide de lavage on va l'évacuer par l'estomac donc le liquide du liquide péripénal il remonte, il circule grâce à des portes et d'estomac pour être évacué dans le canal thoracique mais quand le malade il a un liquide péripénal l'estomac et les portes vont se boucher et le liquide est épais, il ne peut plus être évacué c'est pour ça qu'il commence à développer de la fièvre d'ailleurs le traitement de la péripénale c'est quoi le principal traitement de la péripénale peu importe ça sans les chirurgiens le principal traitement c'est le lavage le traitement, c'est le lavage donc quand vous êtes des chirurgiens vous allez opérer une péripénie la première des choses il faut aspirer des sécrétions épaisses brûlantes et causer une alérographie chacun a sa spécialité chacun va avoir cet épanchement pour les radiologues c'est un épanchement écologique pour moi chirurgien c'est un épanchement qui est sale je dois le nettoyer et puis le principal traitement c'est le lavage par du sérum salé on prend du sérum salé si on opère par exemple le malade il faut réchauffer un peu le sérum pour ne pas entraîner un choc il faut réchauffer il faut laver jusqu'à l'inertissement du liquide donc on verse la première cupule, on aspire on verse une deuxième jusqu'à l'inertissement et le nettoyage de la qualité téléphonique la dernière cupule, c'est je dois laver je dois récupérer l'air quand je l'ai donc le nettoyage de la qualité téléphonique par du sérum salé et puis c'est le drainage et bien sûr il faut traiter la cause si c'est une péripénie à peine mutale si c'est une péripénie si c'est une péripénie par exemple on ferme une cerce qui est perforé donc le principal traitement de la péripénie c'est le lavage de la qualité téléphonique donc la biographie elle met en évidence les fonctions au liquide bien la biologie la numérosité en forme et en vie bien sûr elle va retrouver la critère de l'épositose et il faut bien sûr explorer la fonction des reins parce que tout à l'heure on a parlé du choc qui provoque ce qui veut dire que le rein va souffrir et il va y avoir une influence de drainage fonctionnelle qu'il va falloir corriger avant de démarrer l'expansion c'est la mise en condition c'est la réexpansion et la régravation avant les idéologies les idéologies les idéologies les plus fréquemment rencontrées ce sont une les entamogènes qui diffusent les jeûnes etc qui risquent deuxième cause ce sont les péripénies et puis les perforations coliques les perforations coliques ils peuvent être traumatiques ils peuvent

être tumorales ils peuvent être inflammatoires diverticulaires etc vous allez voir tout ça l'année prochaine dans le cours de la pathologie et puis vous allez avoir des perforations graines des perforations graines peuvent être spontanées des perforations graines spontanées ou bien traumatiques spontanées ce sont des infections typiques par exemple qui peuvent s'accompagner des perforations graines ça peut être toxique ça peut être un corps étranger inhalé dans l'intestin ça peut provoquer des perforations graines on peut avoir des péripérités d'origine hépatobiliaire ça peut être des perforations de la visibilité des péripérités prostopératoires lors de l'intervention pour une pathologie guénière et des ruptures d'oxygène hépatique on peut avoir des péripérités chirurgicales lors des manœuvres d'intervention volontaire de grossesse des perforations de pure odeur de pyosanthèse il peut y avoir des péripérités humides c'est le cas des péripérités par contamination hématogène les péripérités tuberculeuses les péripérités par surinfection du liquide d'acide en conclusion on va dire que la péripérité c'est une maladie c'est une menace ce qui peut être généralisé ou localisé localisé ce sont les affaires ventriculaires et les affaires féministes généralisés qui correspondent aux gens de manière toujours foncées à la préparation avant le geste chirurgical une diagnostic une échantillonne c'est un accord des modèles c'est-à-dire évaluer le diagnostic c'est-à-dire décider du chirurgique de la péripérité et de l'infection de la péripérité